



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 999.7/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN KONTRAK KLINIS DAN MANAJEMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan dan pemenuhan pelayanan sesuai kebutuhan pelayanan untuk di masing masing Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat melakukan kontrak manajemen dan kontrak dengan pihak luar rumah sakit;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kontrak manajemen dan kontrak klinis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, perlu adanya Panduan Penyusunan Kontrak dan Manajemen Klinis RS Prima Husada Malang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika tentang Panduan Penyusunan Kontrak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 4.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA MALANG TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KONTRAK KLINIS DAN MANAJEMEN**

Pasal 1

- (1) RS Prima Husada Malang bertanggung jawab terhadap kontrak atau pengaturan lain untuk memastikan bahwa pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien pada masing masing Rumah Sakit Prima Husada Malang dan merupakan bagian dari kegiatan manajemen serta peningkatan mutu pelayanan

Pasal 2

- (1) Kepala bidang manajemen dan kepala unit berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak manajemen.
- (2) Direktur Rumah Sakit berkoordinasi dengan Kepala bidang pelayanan klinis dan Kepala Unit pelayanan berpartisipasi dan



bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan dan pemantauan kontrak pelayanan klinis.

- (3) Pengadaan RS Prima Husada Malang berkoordinasi dengan Direktur masing masing Rumah sakit Prima Husada Malang dalam rangka pemilihan dan pemantauan kontrak klinis dan kontrak manajemen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa.
- (4) Keputusan kontak klinik dan Kontrak manajemen dilakukan rapat melibatkan Kepala bidang, kepala Instalasi, Direktur Rumah Sakit dan Direktur RS Prima Husada Malang .

Pasal 3

- (1) Kontrak yang dinegosiasikan ulang atau dihentikan maka rumah sakit tetap menjaga kontinuitas dari pelayanan pasien.
- (2) Negosiasi, segala perubahan maupun penghentian kontrak harus atas sepengetahuan dan persetujuan RS Prima Husada Malang .
- (3) Rumah sakit tidak diperkenankan menentukan atau mengambil langkah sepihak terkait kontrak

Pasal 4

- (1) Kontrak dan perjanjian lainnya sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
- (2) Penilaian Kinerja untuk Kontrak kerja Klinis harus memasukkan mutu pelayanan dari pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- (3) RS Prima Husada Malang perlu mendapatkan informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya, lalu menganalisa informasi tersebut kemudian mengambil tindakan berdasar atas data dan informasi tersebut.
- (4) Pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian lainnya perlu mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut.
- (5) Mendapatkan/ menerima laporan mutu dari penyedia kontrak yang kemudian ditindaklanjuti dan Kepala unit pelayanan memastikan bahwa laporan – laporan tersebut diintegrasikan ke dalam proses penilaian mutu rumah sakit.
- (6) Kepala bidang klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi mutu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontrak / pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Direktur RS Prima Husada Malang mendapatkan laporan dari Direktur Rumah Sakit untuk memastikan bahwa dokter praktik mandiri yang bukan merupakan staf Rumah Sakit memiliki izin dan kredensial yang tepat sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit dan peraturan perundang – undangan.
- (2) Direktur RS Prima Husada Malang berkolaborasi dengan Direktur Rumah Sakit yang melibatkan Kepala bidang pelayanan klinis dapat merekomendasikan kontrak atau mengatur pelayanan dari



staf profesional pemberi asuhan (PPA) seperti dokter dokter gigi, dan para praktisi independen lainnya di luar rumah sakit.

- (3) Dokter praktik rumah sakit yang memberikan pelayanan diagnostik, konsultasi, dan layanan perawatan dari luar rumah sakit, seperti kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), radiologi jarak jauh (*teleradiology*), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostic lain seperti elektrokardiogram (EKG), elektroesefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa telah dilakukan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 01 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M. Kes



LAMPIRAN
PERATURAN RS PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 999.7/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KONTRAK

BAB I
DEFINISI

1.1. PENGERTIAN

- 1.1.1. Kontrak pelayanan klinis di sebut kontrak klinis Perjanjian pelayanan klinis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pasien.
- 1.1.2. Kontrak pelayanan manajemen di sebut kontrak manajemen adalah perjanjian yang menunjang kegiatan rumah sakit (dalam memberikan pelayanan kepada pasien).

1.2. FUNGSI

- 1.2.1. Sebagai alat bukti adanya hubungan hukum.
- 1.2.2. Sebagai alat mengantisipasi konflik dikemudian hari.

1.3. TUJUAN

- 1.3.1. Sebagai aturan mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.
- 1.3.2. Memberikan suatu kepastian hukum.
- 1.3.3. Melindungi hak dan kewajiban para pihak.
- 1.3.4. Sebagai pedoman bagi para pihak yang berjanji.



BAB II RUANG LINGKUP

2.1. Jenis Kontrak

2.1.1. Kontrak Klinis

- 1) Kontrak Klinis adalah kontrak kerjasama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien di lingkungan rumah sakit (misal : kerjasama kefarmasian). Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan maupun pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu (misal : kerjasama dengan laboratorium klinis lain)
- 2) Kontrak klinis juga bisa berhubungan dengan staf professional kesehatan, misalnya kontrak perawat untuk pelayanan intensif, dokter tamu/dokter paruh waktu dan lain-lain.
- 3) Ruang lingkup kerjasama kontrak klinis memuat seluruh bentuk kerjasama dengan pihak lain yang bersifat klinis dalam pelayanan kesehatan bagi pasien.

2.1.2. Kontrak manajemen

Kontrak manajemen adalah bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan alat dan atau pelayanan non klinis lainnya (misal : pelayanan parkir, tenaga kerja, makanan dan lain-lain). Ruang lingkup kerjasama ini memuat seluruh bentuk kerjasama dengan pihak lain.

2.2. Prinsip Kontrak

2.2.1. Secara Umum

Secara umum kerjasama yang ditangani oleh RS Prima Husada Malang harus memuat prinsip umum berikut :

- 1) Transparansi
 - (a) Dalam proses perumusan kebijakan oleh RS Prima Husada Malang maka keterbukaan pada masyarakat menjadi suatu control atas kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga.
 - (b) Membuka kesempatan untuk semua pihak mendapat informasi/kesempatan yang sama tentang adanya suatu tender kerjasama.
- 2) Akuntabilitas
Kewajiban rumah sakit untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait penerimaan dan penggunaan anggaran pada RS Prima Husada Malang .
- 3) Partisipatif
Kegiatan mengikutsertakan pihak yang hendak menjalin kerjasama dengan prinsip konsultasi, dialog, negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama.
- 4) Efisiensi
Kerjasama dengan pihak ketiga mempertimbangkan nilai-nilai efektivitas yaitu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dan tujuan terhadap hasil yang diperoleh dalam kerjasama.
- 5) Konsensus
Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga harus memiliki titik temu sehingga mencapai keputusan yang disepakati. Tidak ada keputusan yang ditentukan sepihak yang tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.
- 6) Monitoring dan Evaluasi
Guna kepentingan pemenuhan mutu dan keselamatan pasien maka pihak ketiga bersedia dilakukan evaluasi serta harus menjaga mutu dalam pelayanan maupun penyelenggaraan layanan yang tercantum dalam kontrak meliputi quality control, analisis dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjaga mutu.



7) Saling menguntungkan dan Memajukan

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga harus berdasarkan pemahaman bahwa kedua belah pihak (atau lebih) akan mendapatkan keuntungan yang memberikan dampak kemajuan dan pada organisasi dan kemanfaatan pada masyarakat luas.

2.2.2. Secara Khusus

Selain prinsip utama diatas kerjasama dengan pihak ketiga juga menggunakan prinsip-prinsip berikut :

- 1) Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum
- 2) Ketertikatan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan
- 3) Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat
- 4) Adanya kepastian hukum
- 5) Tertib penyelenggaraan
- 6) Kerjasama dilakukan bukan karena upaya keuntungan perseorangan akan tetapi suatu pertimbangan untuk mencapai tujuan saling mendorong, saling menghormati dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini prinsip khusus juga mengatur antara lain :

- 1) Penunjukan penanggungjawab kerjasama
- 2) Adanya penanggungjawab untuk kontrak klinis
- 3) Adanya penanggungjawab untuk kontrak manajemen
- 4) Pelaksanaan seleksi terhadap kontrak kerjasama perlu didasarkan atas kepatuhan peraturan perundangan yang berlaku
- 5) Adanya penetapan kontrak dan dokumen kontrak yang disepakati kedua belah pihak
- 6) Seluruh kontrak kerjasama akan diawasi (monitoring) dalam rangka menjaga mutu dan keselamatan pasien
- 7) Seluruh kontrak kerjasama akan dilakukan evaluasi oleh kedua belah pihak untuk menganalisis kecocokkan manfaat atas hasil kerjasama yang disepakati. Apabila ada ketidaksesuaian maka :
 - (a) Dapat diberikan teguran.
 - (b) Dapat terjadi penghentian/pembatalan/pemutusan dan pengalihan kontrak apabila mutu pelayanan yang disediakan melalui kontrak tidak sesuai.
 - (c) Dalam mekanisme perpanjangan kontrak, maka kerjasama akan ditinjau ulang guna melihat efektivitas dan kecocokkan manfaat atas kerjasama yang terjalin selama ini.



BAB III
TATA LAKSANA

3.1. Penanggung Jawab Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen

- 3.1.1. Direksi Rumah Sakit Prima Husada Malang berkolaborasi dengan Manajemen PT Disa Prima Medika untuk melakukan kontrak Klinis dan kontrak Manajemen beserta evaluasinya.
- 3.1.2. Kepala Unit berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak pelayanan klinis yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Klinis, dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Direktur dan Manajemen PT Disa Prima Medika.
- 3.1.3. Direktur PT Disa Prima Medika berkoordinasi dengan Direksi RS Prima Husada Malang yang berkolaborasi dengan Kepala Bidang Manajemen dan Kepala Unit dalam berpartisipasi serta bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak manajemen..

3.2. Seleksi Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen

- 3.2.1. Pimpinan klinis melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat klinis dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Prima Husada Malang sehingga perlu dilakukan kontrak klinis.

Cakupan kontrak klinis meliputi :

- 1) Pelayanan Asuhan Pasien dengan Rumah Sakit yang memiliki fasilitas sarana prasarana lebih lengkap.
- 2) Staf profesional Kesehatan Perawat dan atau pelayanan intensif.
- 3) Dokter tamu/Dokter paruh waktu.
- 4) Pelayanan Penyediaan Darah
- 5) Pelayanan Laboratorium
- 6) Pelayanan Radiologi
- 7) Pengelolaan limbah sesuai kebutuhan rumah sakit.
- 8) Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

- 3.2.2. Pimpinan manajemen melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelayanan pasien yang bersifat manajerial dan tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya Rumah Sakit Prima Husada Malang sehingga perlu dilakukan kontrak manajemen.

- 1) Cakupan Kontrak Manajemen meliputi :

- a) Kerjasama penggunaan dan pengelolaan asset Rumah Sakit Prima Husada Malang misal pengelolaan parkir, kantin dan lain-lain. Kerjasama harus dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur RS Prima Husada Malang
- b) Kerjasama dengan supplier alat non medis
 - (1) Untuk pengadaan barang dan atau pemeliharaan sarana dapat melakukan kerjasama dengan rekanan
 - (2) Kerjasama harus dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur RS Prima Husada Malang
 - (3) RS Prima Husada Malang dapat menunjuk Pihak Ketiga sesuai kebutuhan dan dalam kurun waktu sesuai dengan perjanjian
- c) Kerjasama untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk kebutuhan pembangunan, renovasi dan atau pemeliharaan sarana
- d) Kerjasama ketenagakerjaan dapat berupa tenaga kerumahtanggaan, tata graha, keamanan
- e) Kerjasama untuk pemenuhan makanan
- f) Kerjasama untuk pengurusan Linen
- g) Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi

Kerjasama dengan PBF harus memenuhi 8 (delapan) elemen berikut :

- (1) Akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari KEMENKUMHAM
- (2) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- (3) NPWP
- (4) Izin Perdagangan Besar Farmasi / Penyalur Alat Kesehatan (PBF/PAK)
- (5) Perjanjian kerjasama antara distributor dengan principal dan Direktur RS Prima Husada Malang
- (6) Nama dan surat izin kerja apoteker untuk apoteker penanggungjawab PBF
- (7) Alamat dan denah kantor PBF
- (8) Surat Garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan dari principal

2) Metode Penentuan Dalam Seleksi Kontrak

a) Evaluasi administrasi

- (1) Mampu memberikan penjelasan dengan jelas ke RS Prima Husada Malang
- (2) Jelas secara administrasi dan hukum
- (3) Rekomendasi yang baik dari pihak terkait atau memiliki kredibilitas latar belakang yang baik
- (4) Sesuai dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku

b) Evaluasi teknis

- (1) Mampu memberikan penawaran disertai dengan data teknis yang baik, jelas dan detail
- (2) Mampu menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten untuk melakukan penjelasan
- (3) Mampu memberikan demonstrasi dan simulasi
- (4) Mampu memenuhi semua kebutuhan yang diminta rumah sakit dan perusahaan
- (5) Mampu memberikan proses implementasi / instalasi yang baik
- (6) Mampu memberikan garansi teknis yang baik
- (7) Mampu memberikan pendampingan pada saat implementasi / instalasi dan sesudahnya
- (8) Adanya call center yang dapat dihubungi apabila ada masalah
- (9) Layanan purna jual yang baik
- (10) Menjamin ketersediaan barang habis pakai atau barang yang hal yang menjadi objek kerjasama selama satu tahun kedepan

c) Evaluasi harga

- (1) Mampu memberikan harga yang bersaing dengan spesifikasi yang sama
- (2) Mampu memberikan metode pembayaran atau kerjasama yang menguntungkan
- (3) Mampu memberikan *reminder* bila menerapkan kebijakan pembayaran secara bertahap
- (4) Mempunyai administrasi internal yang baik
- (5) Mampu memberikan solusi mengenai biaya pajak yang terkait

3.3. Penetapan Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen

3.3.1. Kontrak klinis

Kontrak klinis disusun berdasarkan kebutuhan klinis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan asuhan pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kontrak klinis sebagai berikut :

- 1) Harus dilakukan proses kredensial yang jelas terhadap pihak penyelenggaran meliputi :
 - (a) Surat izin yang masih berlaku dan sah secara hukum
 - (b) Surat syarat administrasi lain masih berlaku dan sah secara hukum



- (c) Posisi dan alamat kerja yang terverifikasi
- 2) Harus memastikan proses pelayanan tidak membebani pasien
- 3) Harus mendapatkan kepastian mengenai alur dan waktu pelayanan
- 4) Harus mendapatkan kepastian biaya, prosedur penagihan dan pembayaran dengan jelas
- 5) Jika kontrak klinis berkaitan dengan staf professional, maka staf tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan RS Prima Husada Malang dan peraturan perundangan yang berlaku. Proses kontrak klinis staf professional meliputi kredensial, penetapan kontrak, penilaian kinerja, rekredensial hingga pengakhiran kontrak

3.3.2. Kontrak Manajemen

Kontrak manajemen disusun berdasarkan kebutuhan manajemen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Rancangan kontrak manajemen antara lain meliputi :

- 1) Penjelasan Pihak Terkait
- 2) Syarat-syarat umum kontrak meliputi kuantitas, harga, waktu
- 3) Pelaksanaan kontrak
- 4) Penyelesaian kontrak
- 5) Adendum kontrak
- 6) Pemutusan Kontrak
- 7) Hak dan Kewajiban pihak terkait
- 8) Pembayaran biaya
- 9) Pengawasan Mutu
- 10) Sengketa
- 11) Syarat-syarat khusus meliputi spesifikasi, gambar-gambar, dokumen lain
- 12) Tahapan dan penjadwalan
 - (a) Pihak vendor harus memberikan tahapan implementasi dan jadwal yang jelas dan sudah disetujui oleh RS Prima Husada Malang
 - (b) Proses pengerjaan harus mulai diproses pada saat penandatanganan kontrak atau dalam tenggang waktu yang disepakati dan tercantum di dalam kontrak
- 13) Penandatanganan kontrak
 - (a) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
 - (b) Yang berhak melakukan penandatanganan kontrak adalah Direktur RS Prima Husada Malang (dan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang apabila diperlukan)

3.3.3. Proses penetapan kontrak manajemen dan klinis sesuai dengan ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan.

3.3.4. Pimpinan manajemen dan pimpinan klinis ikut terlibat dalam proses seleksi kontrak manajemen dan klinis.

3.4. Dokumen menyebutkan pengalihan tanggung jawab pihak kedua

3.4.1. Tangung jawab pengalihan tanggung jawab pihak kedua karena adanya kerusakan alat yang tidak sesuai dengan kontrak.

3.4.2. Kontrak klinis dikembalikan kepada pihak kedua karena tidak sesuai dengan peraturan Rumah Sakit.

3.5. Monitoring Mutu Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen

3.5.1. Kontrak klinis dan manajemen yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi setiap tahun oleh instalasi atau unit kerja yang sesuai.

3.5.2. Pihak ketiga tetap menjaga kontinuitas pelayanan tiga bulan sebelum kontrak berakhir.

3.5.3. Apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan indikator mutu maka pihak rumah sakit dapat memberikan tindakan.



- 3.5.4. Monitoring kontrak klinis dan manajemen meliputi aspek administrasi dan mutu pelayanan.
- 3.5.5. Aspek Administrasi yang dimonitoring dan di evaluasi masa berlaku izin operasional, dan aspek mutu meliputi waktu masa kontrak di informasikan 1 bulan sebelum masa kontrak berakhir dan masa berlaku sertifikat akreditasi.
- 3.6. Teguran dan Pemutusan Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen
 - 3.6.1. Kontrak klinis akan berakhir apabila :
 - 1) Kontrak dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
 - 2) Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pihak lainnya, apabila pihak lainnya:
 - (a) Melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam kontrak dan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis yang memintanya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut;
 - (b) Dinyatakan pailit, atau menunjuk kurator – kurator atas sebagian asetnya atau mengajukan permohonan kepada para krediturnya untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran
 - (c) Terdapat perintah atau persetujuan untuk diikudasi kecuali perintah atau persetujuan untuk reorganisasi atau penggabungan
 - (d) Menghentikan kegiatan usahanya atau ijin – ijin untuk melakukan usahanya dicabut oleh pihak berwenang
 - (e) Melakukan pelanggaran atas peraturan perundang – undangan yang berlaku yang akan atau dapat mengganggu pelaksanaan kewajibannya kepada pihak lainnya.
 - 3) Apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kontrak, pihak yang diakhiri berhak dan karenanya dengan ini melepaskan atau meniadakan haknya, apabila ada, untuk menuntut atas kerusakan kompensasi atau meminta ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai akibat dari pengakhiran tersebut kecuali atas kewajiban – kewajiban pembayaran yang masih tertunggak terhadap pihak lainnya.
 - 4) Keadaan memaksa (Force Majeure)
 - (a) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “*Force Majeure*”) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, peemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kontrak.
 - (b) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Maejure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk



tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (c) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kontrak.
- (d) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

5) Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit Pihak Pertama.

6) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah yang akan dibayarkan atau diterima sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

3.7. Review kontrak untuk perpanjangan

Review kontrak dibedakan menjadi 2 yaitu :

3.7.1. Kontrak Klinis

3.7.2. Kontrak Manajemen.

Kontrak Manajemen RS Prima Husada Malang untuk masing – masing Rumah Sakit dilakukan kedua belah pihak 3 Bulan sebelum kontrak berakhir, dengan menilai pelayanan agar tercapainya mutu pelayanan yang bagus, Penilaian yang dilakukan meliputi :

- 1) Ketersediaan Barang atau sparepart sesuai dengan kebutuhan pelayanan RS Prima Husada Malang untuk masing masing di Rumah Sakit melakukan review kontrak dari Persediaan Barang habis pakai atau Spare part yang akan perlu di gantikan dengan alat tersebut
- 2) Ketersediaan Teknisi berdasarkan populasi alat di salah suatu kota.
- 3) Penanganan kerusakan peralatan atau kekosongan barang yang berhubungan dengan pelayanan pasien.
- 4) Cara penyampaian hasil atau pengiriman hasil.
- 5) Cara Pembayaran harus di perhitungkan.

Ditetapkan di Malang,
pada tanggal 1 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes